

RECEITA MÉDICA

MÉDICO PRESCRITOR

Nome: fernando

CRM: sfgh

Especialidade: radiologista

Data: 22/02/2026 21:17

PACIENTE

Nome: xavier Tchivela

Idade: 24 anos

Gênero: masculino

DIAGNÓSTICO

TIPO DE EXAME:

Ressonância Magnética

DESCRIÇÃO:

nm

OBSERVAÇÕES:

m

RESULTADO:

****Relatório de Análise de Imagem Médica****

****Paciente:**** Xavier Tchivela

****Idade:**** 24 anos

****Gênero:**** Masculino

****1. Descrição da imagem e qualidade técnica****

A imagem fornecida é uma microfotografia de um esfregaço de sangue periférico corado (provavelmente com coloração tipo Romanowsky, como Giemsa ou Wright). A qualidade técnica da imagem é boa, com clareza adequada para a identificação dos elementos celulares e estruturas parasitárias. O campo de visão mostra uma população predominantemente de eritrócitos.

* ****Nota sobre o tipo de exame:**** É importante ressaltar que, embora o contexto clínico mencione "Ressonância Magnética" como tipo de exame, a imagem apresentada é inequivocamente um esfregaço de sangue periférico sob microscopia óptica, o que é fundamental para a análise hematológica e parasitológica.

****2. Achados principais****

* ****Eritrócitos (Glóbulos Vermelhos):**** Observa-se a presença de anisocitose (variação no tamanho dos eritrócitos) e poiquilocitose (variação na forma dos eritrócitos), com algumas células exibindo hipocromia (centro pálido aumentado).

* ****Parasitas Intraeritrocitários:**** O achado mais significativo é a presença de múltiplos parasitas dentro dos eritrócitos. Estes parasitas se apresentam principalmente como formas anelares (trofozoítos jovens), caracterizadas por pequenos anéis de citoplasma e um ponto de cromatina, e alguns trofozoítos mais maduros. Alguns parasitas parecem conter pigmento malárico (hemozoína). Em alguns eritrócitos, observa-se mais de um parasita.

****3. Diagnóstico sugerido****

Os achados são altamente sugestivos de ****Malária****. A presença de parasitas intraeritrocitários é o critério diagnóstico para infecção malárica. A morfologia predominante de formas anelares e trofozoítos jovens, por vezes múltiplos por eritrócito, é compatível com diversas espécies de *Plasmodium*, incluindo *Plasmodium falc...*
[Diagnóstico completo disponível no sistema]

PRESCRIÇÃO MÉDICA

PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Com base na evidência de parasitemia e na alta urgência, o tratamento antimalárico deve ser iniciado

imediatamente.

1. **Artemeter + Lumefantrina** (Nome comercial sugerido: Coartem® ou similar)

* **Princípio Ativo:** Artemeter 20 mg + Lumefantrina 120 mg (por comprimido)

* **Dosagem:** 4 (quatro) comprimidos por dose

* **Frequência e Duração do Tratamento (Regime de 3 dias):**

* **1ª Dose:** 4 comprimidos, **AGORA** (ou o mais rápido possível).

* **2ª Dose:** 4 comprimidos, 8 horas após a 1ª dose.

* **3ª Dose:** 4 comprimidos, 12 horas após a 2ª dose (ou na manhã do Dia 2).

* **4ª Dose:** 4 comprimidos, 12 horas após a 3ª dose (ou na noite do Dia 2).

* **5ª Dose:** 4 comprimidos, 12 horas após a 4ª dose (ou na manhã do Dia 3).

* **6ª Dose:** 4 comprimidos, 12 horas após a 5ª dose (ou na noite do Dia 3).

* **Via de Administração:** Oral. **Administrar junto com alimentos ou leite**, pois a absorção da Lumefantrina é melhorada por gordura.

* **Quantidade Total a Ser Dispensada:** 24 (vinte e quatro) comprimidos.

2. **Paracetamol**

* **Princípio Ativo:** Paracetamol

* **Dosagem:** 750 mg

* **Frequência:** 1 (um) comprimido, a cada 6 (seis) horas, **SE NECESSÁRIO**, para controle de febre e/ou dor de cabeça.

* **Duração do Tratamento:** Enquanto durarem os sintomas.

* **Via de Administração:** Oral.

* **Quantidade Total a Ser Dispensada:** 1 (uma) caixa com 20 (vinte) comprimidos.

2. **AValiação CLÍNICA URGENTE:** A avaliação deve incluir histórico completo (com foco em viagens para áreas endêmicas), exame físico detalhado e busca por sinais de gravidade (ex: alteração do nível de consciência, convulsões, dificuldade respiratória, icterícia, sangramentos, anemia grave, disfunção renal). Esta avaliação definirá se o tratamento inicial deve ser por via oral ou intravenosa.

3. **CONFIRMAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA ESPÉCIE:**

* Realizar análise mais aprofundada do esfregaço de sangue periférico (gota espessa e esfregaço fino) para **identificação definitiva da espécie de Plasmodium** (importante para *Plasmodium vivax* e *ovale* devido à necessidade de erradicação das formas hepáticas) e **contagem da parasitemia** (número de parasitas por microlitro de sangue).

* Considerar métodos moleculares (como PCR) se a microscopia for inconclusiva ou para confirmar a espécie.

4. **MONITORIZAÇÃO:**

* **Hemograma completo:** Acompanhamento de hemoglobina, hematócrito e plaquetas (anemia e trombocitopenia são comuns na malária).

* **Função Renal e Hepática:** Monitorização de creatinina, ureia, bilirrubinas (total e frações), TGO e TGP.

* **Glicemia:** Monitorização regular, especialmente em casos graves.

* **Parasitemia:** Repetição diária do esfregaço de sangue (gota espessa) para acompanhar a resposta ao tratamento e garantir a negatificação da parasitemia.

5. **REPOSIÇÃO HÍDRICA E NUTRICIONAL:** Manter o paciente bem hidratado (oral ou intravenoso, conforme o estado clínico) e com nutrição adequada.

6. **SINAIS DE ALERTA PARA RETORNAR AO MÉDICO/Piora:**

- * Piora da febre ou febre que não cede com o Paracetamol.
- * Vômitos incoercíveis ou incapacidade de manter a medicação oral.
- * Sonolência excessiva, confusão mental ou qualquer alteração neurológica.
- * Convulsões.
- * Dificuldade para respirar.
- * Sangramentos espontâneos ou manchas roxas na pele.
- * Pele ou olhos amarelados (icterícia).
- * Diminuição da diurese.

7. ****RETORNO:**** O paciente necessitará de ****acompanhamento médico diário**** nos primeiros dias de tratamento para reavaliação clínica e monitoramento da parasitemia. Um infectologista deverá acompanhar o caso.

* ****MALÁRIA É EMERGÊNCIA MÉDICA:**** A detecção de parasitas de malária no sangue requer tratamento imediato. O atraso no tratamento pode levar a complicações graves e óbito.

* ****TRATAMENTO AJUSTÁVEL:**** O regime de tratamento pode ser ajustado com base na espécie de *Plasmodium* identificada, na gravidade da doença, na idade e peso do paciente, e nos padrões de resistência locais.

* ****ARTEMETER + LUMEFANTRINA:****

* ****Efeitos Colaterais Comuns:**** Cefaleia, tontura, náuseas, vômitos, dor abdominal, palpitações. Caso ocorram efeitos adversos graves, procurar atendimento médico.

* ****Interações Medicamentosas:**** Informar ao médico sobre todos os medicamentos (incluindo fitoterápicos e suplementos) que o paciente esteja utilizando, pois pode haver interações importantes.

* ****Gravidez/Amamentação:**** Não se aplica ao paciente, mas em outros contextos, a medicação deve ser usada com cautela em grávidas ou lactantes.

* ****TESTE DE DEFICIÊNCIA DE G6PD:**** Antes de qualquer consideração de tratamento com Primaquina (necessária para *P. vivax* e *P. ovale* ou como gametocitocida para *P. falciparum*), é ****fundamental realizar a pesquisa de deficiência de Glicose-6-Fosfato Desidrogenase (G6PD)****, devido ao risco de hemólise em pacientes deficientes. A Primaquina **NÃO** está prescrita neste momento.

Atenciosamente,

****Dr. Fernando****

Radiologista

CRM: sfgh

****(Carimbo do Consultório)****

(Endereço e Telefone para Contato)

RECOMENDAÇÕES

RECOMENDAÇÕES MÉDICAS ESPECÍFICAS

1. ****URGÊNCIA E INTERNAÇÃO:**** Dada a alta urgência e a suspeita de *Plasmodium falciparum*, o paciente ****Xavier Tchivela** deve ser encaminhado **IMEDIATAMENTE** para avaliação médica presencial em unidade de saúde (Pronto-Socorro ou hospital) ****** para avaliação clínica completa e determinação da gravidade do quadro. A hospitalização pode ser necessária.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

IMPORTANTE:

Esta receita foi baseada no diagnóstico do paciente. Em caso de dúvidas, consultar o médico prescritor.

fernando
CRM: sfgh
radiologista

Receita gerada em 22/02/2026 21:17

ID da receita: 2

Sistema Médico - Receita eletrônica